



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PANDUAN RUJUKAN TAHUN 2025

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Nomor 319.38/I-PND/IGD/IV/2025

Tentang
Panduan Rujukan

Disusun oleh :
Penanggung Jawab TIM AKP



(Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Rujukan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada. Panduan Rujukan ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sistem, alur, wewenang dan tanggung jawab layanan rujukan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Rujukan ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Prima Husada.

Malang, 04 April 2025

Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN
PANDUAN RUJUKAN

Pengarah :

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

Pelaksana :

1. dr. Nur Mazidah
2. Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns
3. Ratih Aji Suryamanjari, S.Kep., Ns
4. Murwani Suryaning Sapartinah, A.Md. Kep
5. Ferianto Hendri Cahyono, AMd. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR.....ii

TIM PENYUSUNiii

DAFTAR ISI.....iv

PERATURAN DIREKTUR v

BAB I DEFINISI 1

BAB II RUANG LINGKUP 2

BAB III TATA LAKSANA..... 3

 3.1 Keputusan Melakukan Rujukan 3

 3.2 Stabilisasi Sebelum Rujukan 5

 3.3 Pendampingan Pasien Selama Rujukan 6

 3.4 Kompetensi Pendamping dan Peralatan yang harus Dibawa Selama Rujukan..... 7

 3.5 Pemantauan, Obat-obatan dan Peralatan Selama Rujukan Pasien Kritis. 8

 3.6 Pemilihan Metode Rujukan..... 12

 3.7 Alat Transportasi untuk Rujukan..... 12

 3.8 Dokumentasi Rujukan 13

 3.9 Komunikasi dalam Rujukan 13

 3.10 Audit dan Jaminan Mutu..... 14

BAB IV DOKUMENTASI 15

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 319.38/I-PND/IGD/IV/2025**

**TENTANG
PANDUAN RUJUKAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa keterbatasan kemampuan pelayanan Rumah Sakit Prima Husada, maka untuk memenuhi kebutuhan pasien diperlukan rujukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Rujukan Pasien;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan No 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PANDUAN RUJUKAN PASIEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif;
- (2) Rujukan adalah pemindahan pasien dari Rumah Sakit Prima Husada ke fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk mendapatkan pelayanan dan asuhan sesuai kebutuhan pasien;
- (3) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

**BAB II
ALUR RUJUKAN PASIEN**

Pasal 2

- (1) Rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal;



- (2) Rujukan dilaksanakan untuk memenuhi kemampuan pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhan pasien untuk kesinambungan asuhan pasien;
- (3) Rujukan dilaksanakan setelah memastikan bahwa fasilitas pelayanan indakan yang menerima dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk;
- (4) Rumah sakit mempunyai kerjasama dengan rumah sakit yang menerima rujukan.

Pasal 3

- (1) Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga indakan yang berwenang;
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Diagnosis dan terapi dan/atau indakan medis yang diperlukan;
 - b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. Transportasi rujukan;
 - e. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

BAB III

PROSES RUJUKAN PASIEN

Pasal 4

- (1) Dalam proses rujukan harus dengan surat pengantar rujukan ;
- (2) Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas pasien;
 - b. Nama dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima dan nama orang yang menyetujui menerima pasien;
 - c. Alasan pasien dirujuk, memuat kondisi pasien, dan kebutuhan pelayanan lebih lanjut;
 - d. Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan;
 - e. Diagnosis kerja;
 - f. Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - g. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan rujukan.

Pasal 5

- (1) Dalam proses rujukan ada staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan termasuk untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien;
- (2) Selama proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu melakukan monitoring kondisi pasien;

- (3) Selama proses rujukan tersedia obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan, dan peralatan medis sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien.
- (4) Dilaksanakan proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima.

Pasal 6

Proses rujukan dievaluasi dalam aspek mutu dan keselamatan pasien.

Pasal 7

Pasien dan keluarga dijelaskan apabila rujukan yang dibutuhkan tidak dapat dilaksanakan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR 319.38/I-PND/IGD/IV/2025
TENTANG
PANDUAN RUJUKAN PASIEN

BAB I

DEFINISI

Rujukan pasien dapat dilakukan apabila kondisi pasien layak untuk di rujukan. Prinsip dalam melakukan rujukan pasien adalah memastikan keselamatan dan keamanan pasien saat menjalani rujukan. Pelaksanaan rujukan pasien dapat dilakukan intra rumah sakit atau antar rumah sakit.

Rujukan pasien dimulai dengan melakukan koordinasi dan komunikasi pra transportasi pasien, menentukan SDM yang akan mendampingi pasien, menyiapkan peralatan yang disertakan saat rujukan dan monitoring pasien selama rujukan. Rujukan pasien hanya boleh dilakukan oleh staf medis dan staf keperawatan yang kompeten serta petugas profesional lainnya yang sudah terlatih.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Rujukan pasien meliputi pengaturan tentang:

1. Tata laksana rujukan
 - a. Rujukan pasien dari Rumah Sakit Prima Husada ke rumah sakit lain atau sebaliknya
 - b. Rujukan pasien dari Rumah Sakit Prima Husada ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan primer atau perorangan
2. Keputusan merujuk
3. Stabillisasi sebelum merujuk
4. Pendampingan pasien selama merujuk
5. Kompetensi pendamping pasien dan peralatan yang harus dibawa selama rujukan

BAB III

TATA LAKSANA

1. Berikan penjelasan dan meminta persetujuan untuk rujukan gunakan form pemberian informasi rujukan
2. Bila pasien / keluarga memolak rujukan, berikan penjelasan konsekuensi dari penolakannya, tulis dalam form pemberian informasi edukasi
3. Bila pasien/ keluarga tetap menolak rujukan minta agar pasien/ keluarga membuat rujukan dan menandatangani penolakan rujukan
4. Rumah Sakit Prima Husada memiliki suatu tim rujukan yang terdiri dari dokter senior (dokter ICU), DPJP, dokter IGD, dokter ruangan, PPJA, perawat yang kompeten dalam merawat pasien kritis (perawat ICU), staf klinis lain, dan petugas ambulans. Tim ini yang berwenang untuk memutuskan metode rujukan mana yang akan dipilih
5. Berikut adalah metode rujukan yang ada di Rumah Sakit Prima Husada
 - a. Layanan Antar-Jemput Pasien: merupakan layanan / jasa umum khusus untuk pasien Rumah Sakit Prima Husadadengan tim rujukandari petugas IGD, di mana tim tersebut akan mengambil / menjemput pasien dari rumah / rumah sakit jejaring untuk dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada
 - b. Tim rujukanlokal: Rumah Sakit Prima Husada memiliki tim rujukannya sendiri dan mengirimkan sendiri pasiennya ke rumah sakit lain
6. Rumah Sakit Prima Husada mempunyai sistem resusitasi, stabilisasi, dan rujukan untuk pasien-pasien dengan sakit berat / kritis; tanpa terkecuali
7. Dokter senior / DPJP/ dokter ICU yang bertanggungjawab dalam tim rujukan pasien harus siap sedia 24 jam untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan rujukan pasien sakit berat / kritis antar-rumah sakit

3.1 Keputusan Melakukan Rujukan

1. Lakukan pendekatan yang sistematis dalam proses rujukan pasien.
2. Awali dengan pengambilan keputusan untuk melakukan rujukan, kemudian lakukan stabilisasi pra-rujukan dan manajemen rujukan.
3. Hal ini mencakup tahapan: evaluasi, komunikasi, dokumentasi / pencatatan, pemantauan, penatalaksanaan, penyerahan pasien antar ruangan dalam rumah sakit maupun ke rumah sakit rujukan / penerima, dan kembali ke rumah sakit.
4. Tahapan yang penting dalam menerapkan proses rujukan yang aman edukasi dan persiapan.
5. Pengambilan keputusan untuk melakukan rujukan harus dipertimbangkan dengan matang karena rujukan berpotensi mengekspos pasien dan personel rumah sakit akan risiko bahaya tambahan, serta menambah kecemasan keluarga dan kerabat pasien.
6. Pertimbangkan risiko dan keuntungan dilakukannya rujukan. Jika risikonya lebih besar, sebaiknya jangan melakukan rujukan.
7. Dalam rujukan pasien, diperlukan personel yang terlatih dan kompeten, peralatan dan kendaraan khusus.
8. Pengambil keputusan harus melibatkan DPJP/ dokter senior (biasanya seorang konsultan) dan dokter ruangan.
9. Dokumentasi pengambilan keputusan harus mencantumkan nama dokter yang mengambil keputusan (berikut gelar dan biodata detailnya), tanggal dan waktu diambilnya keputusan, serta alasan yang mendasari.
10. Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/ atau keluarganya. Persetujuan diberikan setelah pasien dan/ atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang meliputi :
 - a. Diagnosis dan terapi dan/ atau tindakan medis yang diperlukan

-
- b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan
 - c. Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan
 - d. Transportasi rujukan
 - e. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan
11. Perujuk sebelum melakukan rujukan harus:
- a. Melakukan pertolongan pertama dan/ atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat. Dalam hal ini penerima rujukan berkewajiban menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan dan memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
 - c. Membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan memuat:
 - 1) Identitas pasien
 - 2) Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan
 - 3) Diagnosis kerja
 - 4) Terapi dan / atau tindakan yang telah diberikan
 - 5) Tujuan rujukan
 - 6) Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
12. Terdapat 3 alasan untuk melakukan rujukan pasien keluar rumah sakit
- a. Rujukan untuk penanganan dan perawatan spesialisasi lebih lanjut
 - 1) Ini merupakan situasi emergensi di mana sangat diperlukan rujukan yang efisien untuk tatalaksana pasien lebih lanjut, yang tidak dapat disediakan Rumah Sakit Prima Husada
 - 2) Pasien harus stabil dan teresitasi dengan baik sebelum dirujukan
 - 3) Saat menghubungi jasa ambulan, pasien dapat dikategorikan sebagai tipe rujukan 'gawat darurat', (misalnya ruptur aneurisma aorta. juga dapat dikategorikan sebagai tipe rujukan 'gawat', misalnya pasien dengan kebutuhan hemodialisa
 - b. Rujukan antar rumah sakit untuk alasan non-medis (misalnya karena ruangan penuh, fasilitas kurang mendukung, jumlah petugas rumah sakit tidak adekuat)
 - 1) Idealnya, pasien sebaiknya tidak dirujukan jika bukan untuk kepentingan mereka
 - 2) Terdapat beberapa kondisi di mana permintaan / kebutuhan akan tempat tidur/ ruang rawat inap melebihi suplai sehingga diputuskanlah tindakan untuk men rujukan pasien ke unit / rumah sakit lain
 - 3) Pengambilan keputusan haruslah mempertimbangkan aspek etika, apakah akan men rujukan pasien stabil yang telah berada / dirawat di unit intensif rumah sakit atau men rujukan pasien baru yang membutuhkan perawatan intensif tetapi kondisinya tidak stabil
 - 4) Saat menghubungi jasa ambulan, pasien ini dapat dikategorikan sebagai tipe rujukan 'gawat'
 - c. Repatriasi / Pemulangan Kembali
 - 1) Rujukan hanya boleh dilakukan jika pasien telah stabil dan kondisinya dinilai cukup baik untuk menjalani rujukan oleh DPJP/ dokter senior / konsultan yang merawatnya
 - 2) Pertimbangan akan risiko dan keuntungan dilakukannya rujukan harus dipikirkan dengan matang dan dicatat
 - 3) Jika telah diputuskan untuk melakukan repatriasi, rujukan pasien ini haruslah menjadi prioritas di rumah sakit penerima dan biasanya lebih diutamakan dibandingkan penerimaan pasien elektif ke unit ruang rawat. Hal ini juga membantu menjaga hubungan baik antar-rumah sakit

- 4) Saat menghubungi jasa ambulan, pasien ini biasanya dikategorikan sebagai tipe rujukan 'elektif'
13. Saat keputusan rujukan telah diambil, dokter yang bertanggung jawab/ dokter ruangan akan menghubungi rumah sakit yang dituju.
14. Dalam merujuk pasien, tim rujukan Rumah Sakit Prima Husada (DPJP/ PPJA/ dr ruangan) akan menghubungi rumah sakit yang dituju dan melakukan negosiasi dengan unit yang dituju. Jika unit tersebut setuju untuk menerima pasien rujukan, tim rujukan Rumah Sakit Prima Husada harus memastikan tersedianya peralatan medis yang memadai di rumah sakit yang dituju.
15. Keputusan final untuk melakukan rujukan ke luar Rumah Sakit Prima Husada dipegang oleh dokter senior / DPJP/ konsultan rumah sakit yang dituju.
16. Beritahukan kepada pasien (jika kondisinya memungkinkan) dan keluarga mengenai perlunya dilakukan rujukan antar rumah sakit, dan mintalah persetujuan tindakan rujukan.
17. Proses pengaturan rujukan ini harus dicatat dalam status rekam medis pasien yang meliputi: nama, jabatan, dan detail kontak personel yang membuat kesepakatan baik di rumah sakit yang merujuk dan rumah sakit penerima; tanggal dan waktu dilakukannya komunikasi antar-rumah sakit; serta saran-saran / hasil negosiasi kedua belah pihak.
18. Personel tim rujukan harus mengikuti pelatihan rujukan; memiliki kompetensi yang sesuai; berpengalaman; mempunyai peralatan yang memadai; dapat bekerjasama dengan jasa pelayanan ambulan, protokol dan panduan rumah sakit, serta pihak-pihak lainnya yang terkait; dan juga memastikan proses rujukan berlangsung dengan aman dan lancar tanpa mengganggu pekerjaan lain di rumah sakit yang merujuk.
19. Pusat layanan ambulan harus diberitahu sesegera mungkin jika keputusan untuk melakukan rujukan telah dibuat, bahkan bila waktu pastinya belum diputuskan. Hal ini memungkinkan layanan ambulan untuk merencanakan pengerahan petugas dengan lebih efisien.

3.2 Stabilisasi Sebelum Rujukan

1. Meskipun berpotensi memberikan risiko tambahan terhadap pasien, rujukan yang aman dapat dilakukan bahkan pada pasien yang sakit berat / kritis (*extremely ill*)
2. Rujukan sebaiknya tidak dilakukan bila kondisi pasien belum stabil
3. Hipovolemia adalah kondisi yang sulit ditoleransi oleh pasien akibat adanya akselerasi dan deselerasi selama rujukan berlangsung, sehingga hipovolemia harus sepenuhnya dikoreksi sebelum di rujuk
4. Unit/ rumah sakit yang dituju untuk rujukan harus memastikan bahwa ada prosedur / pengaturan rujukan pasien yang memadai
5. Perlu waktu hingga beberapa jam mulai dari setelah pengambilan keputusan dibuat hingga pasien dirujuk ke unit/ rumah sakit lain
6. Hal yang penting untuk dilakukan sebelum rujukan :
 - a. Amankan patensi jalan napas. Beberapa pasien mungkin membutuhkan intubasi atau trakeostomi dengan pemantauan *end-tidal carbondioxide* yang adekuat.
 - b. Analisis gas darah harus dilakukan pada pasien yang menggunakan ventilator portabel selama minimal 15 menit.
 - c. Terdapat jalur / akses vena yang adekuat (minimal 2 kanula perifer atau sentral)
 - d. Pengukuran tekanan darah invasif yang kontinu / terus-menerus merupakan teknik terbaik untuk memantau tekanan darah pasien selama proses rujukan berlangsung.
 - e. Jika terdapat pneumotoraks, selang drainase dada (*Water-Sealed Drainage-WSD*) harus terpasang dan tidak boleh diklem.
 - f. Pasang kateter urin dan *nasogastric tube* (NGT), jika diperlukan
 - g. Pemberian tatalaksana tidak boleh ditunda saat menunggu pelaksanaan rujukan
7. Rumah sakit yang dituju dapat memberikan saran mengenai penanganan segera / resusitasi yang perlu dilakukan terhadap pasien pada situasi-situasi khusus, namun tanggung jawab tetap pada tim rujukan.

8. Tim rujukan harus familiar dengan peralatan yang ada dan secara independen menilai kondisi pasien.
9. Seluruh peralatan dan obat-obatan harus dicek ulang oleh petugas rujukan.
10. Gunakanlah daftar persiapan rujukan pasien (lampiran 1) untuk memastikan bahwa semua persiapan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada yang terlewat

3.3 Pendampingan Pasien Selama Rujukan

1. Pasien dengan sakit berat / kritis harus didampingi oleh minimal 2 orang tenaga medis
2. Kebutuhan akan jumlah tenaga medis / petugas yang mendampingi pasien bergantung pada kondisi / situasi klinis dari tiap kasus (tingkat / derajat beratnya penyakit / kondisi pasien)
3. Dokter senior (dr ICU/ dr Anestesi), bertugas untuk membuat keputusan dalam menentukan siapa saja yang harus mendampingi pasien selama rujukan berlangsung
4. Sebelum melakukan rujukan, petugas yang mendampingi harus paham dan mengerti akan kondisi pasien dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan proses rujukan
5. Berikut ini adalah pasien-pasien yang tidak memerlukan dampingan dr ICU/ dr Anestesi selama proses rujukan antar-rumah sakit berlangsung
 - a. Pasien yang dapat mempertahankan patensi jalan napasnya dengan baik dan tidak membutuhkan bantuan ventilator / oksigenasi
 - b. Pasien dengan perintah 'Do Not Resuscitate' (DNR)
 - c. Pasien yang dirujukan untuk tindakan manajemen definitif akut di mana intervensi anestesi tidak akan mempengaruhi hasil.
6. Berikut adalah panduan perlu atau tidaknya dilakukan rujukan berdasarkan tingkat / derajat kebutuhan perawatan pasien kritis. (keputusan harus dibuat oleh dokter ICU/ DPJP)
 - a. Derajat 0
Pasien yang dapat terpenuhi kebutuhannya dengan ruang rawat biasa di unit/ rumah sakit yang dituju; biasanya tidak perlu didampingi oleh dokter, perawat, atau paramedis (selama rujukan)
 - b. Derajat 1
Pasien dengan risiko perburukan kondisi, atau pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di *High Care Unit* (HCU); di mana membutuhkan perawatan di ruang rawat biasa dengan saran dan dukungan tambahan dari tim perawatan kritis; dapat didampingi oleh perawat, petugas ambulan, dan atau dokter (selama rujukan)
 - c. Derajat 2
Pasien yang membutuhkan observasi / intervensi lebih ketat, termasuk penanganan kegagalan satu sistem organ atau perawatan pasca-operasi, dan pasien yang sebelumnya dirawat di HCU; harus didampingi oleh petugas yang kompeten, terlatih, dan berpengalaman (biasanya dokter dan perawat / paramedis lainnya)
 - d. Derajat 3
Pasien yang membutuhkan bantuan pernapasan lanjut (*advanced respiratory support*) atau bantuan pernapasan dasar (*basic respiratory support*) dengan dukungan / bantuan pada minimal 2 sistem organ, termasuk pasien-pasien yang membutuhkan penanganan kegagalan multi-organ; harus didampingi oleh petugas yang kompeten, terlatih, dan berpengalaman (biasanya dokter anestesi dan perawat ruang intensif / IGD atau paramedis lainnya)
7. Saat Dr ICU/ DPJP di Rumah Sakit Prima Husada tidak dapat menjamin terlaksananya bantuan / dukungan anestesiologi yang aman selama proses rujukan; pengambilan keputusan haruslah mempertimbangkan prioritas dan risiko terkait rujukan.
8. Semua petugas yang tergabung dalam tim rujukan untuk pasien dengan sakit berat / kritis harus kompeten, terlatih, dan berpengalaman.
9. Petugas yang mendampingi harus membawa telepon genggam selama rujukan berlangsung yang berisi nomor telphon Rumah Sakit Prima Husada dan rumah sakit tujuan.
10. Keselamatan adalah parameter yang penting selama proses rujukan.

3.4 Kompetensi Pendamping dan Peralatan yang harus Dibawa Selama Rujukan

Tabel 2.1 Derajat Pasien

Derajat	Petugas pendamping (minimal)	Keterampilan yang dibutuhkan	Peralatan Utama dan Jenis Kendaraan
0	petugas ambulan	Bantuan hidup dasar (BHD)	Kendaraan HDS*/ Ambulan
0,5 orang tua/delirium	petugas ambulan dan paramedic	Bantuan hidup dasar	Kendaraan HDS*/ Ambulan
1	Petugas ambulan dan perawat	• Bantuan hidup dasar • Pemberian oksigen • Pemberian obat-obatan • Kenal akan tanda deteriorasi • Keterampilan perawatan trakeostomi dan <i>suction</i>	• Kendaraan HDS/ Ambulan • Oksigen • <i>Suction</i> • Tiang infus portabel • Infus pump baterai • Oksimetri
2	Dokter, perawat,dan petugas ambulans	• Semua ketrampilan di atas, ditambah: • Penggunaan alat pernapasan • Bantuan hidup lanjut • Penggunaan kantong pernapasan (<i>bag-valve mask</i>) • Penggunaan defibrillator • Penggunaan monitor intensif	• Ambulans transport • Semua peralatan di atas, ditambah; • Monitor EKG dan tekanan darah • <i>Defibrillator</i> bila diperlukan
3	Dokter, perawat, dan petugas ambulan	Dokter: • Minimal 6 bulan pengalaman mengenai perawatan pasien intensif dan bekerja di ICU • Keterampilan bantuan hidup dasar dan lanjut • Keterampilan menangani permasalahan jalan napas dan pernapasan, minimal level ST 3 atau sederajat. • Harus mengikuti pelatihan untuk rujukan pasien dengan sakit berat / kritis Perawat: • Minimal 2 tahun bekerja di ICU • Keterampilan bantuan hidup dasar dan lanjut • Harus mengikuti pelatihan untuk rujukan pasien dengan sakit berat / kritis	• Ambulans Gawat Darurat • Monitor ICU portabel yang lengkap • Ventilator dan peralatan rujukan yang memenuhi standar minimal.

*HDS *High Dependency Service*

KOMPETENSI UNTUK RUJUKAN PASIEN DENGAN SAKIT BERAT / KRITIS DERAJAT 3

Semua pasien sakit berat / kritis derajat 3 didampingi oleh 2 orang selama rujukan. Satu orang adalah dokter, biasanya spesialis anestesi yang sudah terlatih dalam penanganan jalan napas. Satu orang lagi adalah perawat atau dokter umum. Terdapat standar keterampilan minimal untuk melakukan rujukan pasien. Berikut adalah kompetensi yang diperlukan :

Tabel 2.2 Kompetensi Petugas

No	Kompetensi	Keterangan
1	Dokter	Harus memiliki: 1. Minimal 6 bulan pengalaman mengenai perawatan pasien intensif dan bekerja di ICU 2. Keterampilan bantuan hidup dasar dan lanjut 3. Keterampilan menangani permasalahan jalan napas dan pernapasan, minimal level ST 3 atau sederajat. 4. Harus mengikuti pelatihan untuk rujukan pasien dengan sakit berat / kritis
2	Perawat	Harus memiliki: 1. Minimal 2 tahun bekerja di ICU 2. Keterampilan bantuan hidup dasar dan lanjut 3. Harus mengikuti pelatihan untuk rujukan pasien dengan sakit berat / kritis
Peralatan		
3	Ventilator	Dokter harus: a. Memiliki pengetahuan yang cukup terhadap fungsi dan jenis ventilator yang digunakan b. Mampu mengganti baterai c. Mampu mengganti tabung oksigen dan menghitung kebutuhan oksigen pasien Perawat harus: a. mampu mengganti tabung oksigen b. mampu mengganti baterai
4	Pompa	Dokter dan perawat harus: a. Mampu mengganti baterai b. Mampu mengoperasikan jarum suntik / <i>syringe pumps</i> c. Mampu mengatur kecepatan infus dan memberikan bolus cairan / obat
5	Monitor	Dokter dan perawat harus dapat: a. Mendeteksi adanya gelombang yang invasive b. Melakukan pemantauan invasive c. Mengoperasikan EKG d. Mengoperasikan kapnografi e. Mengoperasikan oksimetri denyut
6	Kantong peralatan medis untuk rujukan (<i>rujukan bag</i>)	Dokter dan perawat harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai isi kantong peralatan medis
7	Troli rujukan	Dokter dan perawat harus mengetahui cara mengoperasikan troli dan mengamankan pasien serta peralatan di dalamnya.
8	Sistem bidai untuk rujukan via udara	Dokter dan perawat harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai cara mengoperasikan sistem ini.
9	Pengangkutan Pasien	Dokter dan perawat harus dapat mendemonstrasikan cara mengangkut pasien dengan aman.

10	Komunikasi dan Panduan	Dokter dan perawat harus dapat: 1. Mendemonstrasikan cara berkomunikasi dengan rumah sakit tujuan dan pusat layanan ambulans. 2. Membaca dan memahami kebijakan rujukan setempat dan nasional 3. Memiliki pengetahuan mengenai struktur kendali dan pemberian perintah untuk rujukan
11	Rujukan	Dokter dan perawat harus mempunyai pengetahuan yang cukup akan risiko yang dapat terjadi selama melakukan rujukan pada pasien dengan sakit berat / kritis via menggunakan kendaraan yang bergerak (baik pada transportasi darat maupun udara), dan waspada akan bahaya yang mungkin terjadi kepada petugas dan atau pasien.
12	Penyerahan Pasien	Dokter dan perawat harus mengetahui prosedur serah-terima pasien di rumah sakit tujuan.
13	Orientasi	Dokter dan perawat telah mengetahui kondisi di dalam kendaraan transportasi yang akan digunakan (ambulans atau pesawat) sebelum melakukan rujukan.
14	Panduan Pemantauan Minimal	Dokter harus memiliki pengetahuan mengenai panduan pemantauan minimal.

3.5 Pemantauan, Obat-obatan dan Peralatan Selama Rujukan Pasien Kritis

1. Pasien dengan kebutuhan perawatan kritis memerlukan pemantauan selama proses rujukan.
2. Standar pelayanan dan pemantauan pasien selama rujukan setidaknya harus sebaik pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada/ RS tujuan.
3. Peralatan pemantauan harus tersedia dan berfungsi dengan baik sebelum rujukan dilakukan. Standar minimal untuk rujukan pasien antara lain :
 - a. Kehadiran petugas yang kompeten secara kontinu selama rujukan
 - b. EKG kontinu
 - c. Pemantauan tekanan darah (non-invasif)
 - d. Saturasi oksigen (oksimetri denyut)
 - e. Terpasangnya jalur intravena
 - f. Terkadang memerlukan akses ke vena sentral
 - g. Peralatan untuk memantau *cardiac output*
 - h. Pemantauan *end-tidal carbon dioxide* pada pasien dengan ventilator
 - i. Mempertahankan dan mengamankan jalan napas
 - j. Pemantauan temperatur pasien secara terus-menerus (untuk mencegah terjadinya hipotermia atau hipertermia)
4. Pengukuran tekanan darah non-invasif intermiten, sensitif terhadap gerakan dan tidak dapat diandalkan pada mobil yang bergerak. Selain itu juga cukup menghabiskan baterai monitor.
5. Pengukuran tekanan darah invasif yang kontinu (melalui kanula arteri) disarankan.
6. Idealnya, semua pasien derajat 3 harus dipantau pengukuran tekanan darah secara invasif selama rujukan (wajib pada pasien dengan cedera otak akut; pasien dengan tekanan darah tidak stabil atau berpotensi menjadi tidak stabil; atau pada pasien dengan inotropik).
7. Kateterisasi vena sentral tidak wajib tetapi membantu memantau *filling status* (status volume pembuluh darah) pasien sebelum rujukan. Akses vena sentral diperlukan dalam pemberian obat inotropik dan vasopressor.
8. Pemantauan tekanan intracranial mungkin diperlukan pada pasien-pasien tertentu.
9. Pada pasien dengan pemasangan ventilator, lakukan pemantauan suplai oksigen, tekanan pernapasan (*airway pressure*), dan pengaturan ventilator.²

10. Tim rujukan yang terlibat harus memastikan ketersediaan obat-obatan yang diperlukan, antara lain : (sebaiknya obat-obatan ini sudah disiapkan di dalam jarum suntik)
 - a. Obat resusitasi dasar: epinefrin, anti-aritmia³
 - b. Obat sedasi
 - c. Analgesik
 - d. Relaksans otot
 - e. Obat inotropik
11. Hindari penggunaan tiang dengan selang infus yang terlalu banyak agar akses terhadap pasien tidak terhalang dan stabilitas brankar terjaga dengan baik.
12. Semua infus harus diberikan melalui *syringe pumps*.
13. Penggunaan tabung oksigen tambahan harus aman dan terpasang dengan baik.
14. Petugas rujukan harus familiar dengan seluruh peralatan yang ada di ambulans.
15. Pertahankan temperature pasien, lindungi telinga dan mata pasien selama rujukan.
16. Seluruh peralatan harus kokoh, tahan lama, dan ringan.
17. Peralatan listrik harus dapat berfungsi dengan menggunakan baterai (saat tidak disambungkan dengan stop kontak/listrik).
18. Baterai tambahan harus dibawa (untuk mengantisipasi terjadinya mati listrik)
19. Monitor yang portabel harus mempunyai layar yang jernih dan terang dan dapat memperlihatkan elektrokardiogram (EKG), saturasi oksigen arteri, pengukuran tekanan darah (non-invasif), kapnografi, dan temperatur.
20. Pengukuran tekanan darah non-invasif pada monitor portabel dapat dengan cepat menguras baterai dan tidak dapat diandalkan saat terdapat pergerakan eksternal / vibrasi (getaran).
21. Alarm dari alat harus terlihat jelas dan terdengar dengan cukup keras.
22. Ventilator mekanik yang portabel harus mempunyai (minimal):
 - a. Alarm yang berbunyi jika terjadi tekanan tinggi atau terlepasnya alat dari tubuh pasien
 - b. Mampu menyediakan tekanan akhir ekspirasi positif (*positive end expiratory pressure*) dan berbagai macam konsentrasi oksigen inspirasi
 - c. Pengukuran rasio inspirasi: ekspirasi, frekuensi pernapasan per-menit, dan volume tidal.
 - d. Mampu menyediakan ventilasi tekanan terkendali (*pressure-controlled ventilation*) dan pemberian tekanan positif berkelanjutan (*continuous positive airway pressure*)
23. Semua peralatan harus terstandarisasi sehingga terwujudnya suatu proses rujukan yang lancar dan tidak adanya penundaan dalam pemberian terapi / obat-obatan.
24. Catatlah status pasien, tanda vital, pengukuran pada monitor, tatalaksana yang diberikan, dan informasi klinis lainnya yang terkait. Pencatatan ini harus dilengkapi selama rujukan.
25. Pasien harus dipantau secara terus-menerus selama rujukan dan dicatat di lembar pemantauan.
26. Monitor, ventilator, dan pompa harus terlihat sepanjang waktu oleh petugas dan harus dalam posisi aman di bawah level pasien

PERALATAN RUJUKAN MINIMAL

1. Manajemen jalan napas / oksigenasi (dewasa dan anak)	6. Jarum untuk <i>bone marrow</i> (sum-sum tulang belakang) untuk infus pada anak
a. Sistem <i>bag-valve</i> dewasa dan anak dengan reservoir oksigen	7. Pengukur tekanan darah
b. Sungkup dewasa dan anak	8. <i>Winged needle</i>
c. Penghubung sistem <i>bag-valve</i> dengan <i>endotracheal (ETT)/ tracheostomy tube</i>	9. Telepon genggam
d. Monitor <i>end-tidal carbon dioxide</i> (dewasa dan anak)	10. Gel / bantalan elektroda defibrillator
e. Laringoskop Miller	11. Stik gula darah sewaktu (GDS)
f. Stilet / mandrin ETT (dewasa dan anak)	12. Monitor EKG / defibrillator
	13. Elektroda EKG
	14. Senter dengan baterai cadangan
	15. Pompa infus (<i>infusion pumps</i>)
	16. Selang infus
	17. <i>Three-way</i>

g. Forceps Magil (dewasa dan anak)	18. Kateter intravena
h. Selang ETT (5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0)	19. Cairan infus (normal saline-NS, ringer laktat-RL, dekstroza 5%)
i. Pegangan laringoskop (dewasa dan anak)	20. Sduit
j. Baterai cadangan dan bola lampu laringoskop	21. Klem Kelley
k. <i>Nasopharyngeal airways (NPA)</i> / <i>Oropharyngeal airways (OPA)</i>	22. Oksimetri denyut
l. Pisau bedah (<i>scalpel</i>)	23. <i>Nasogastric tube (NGT)</i>
m. Alat krikotiroidotomi	24. Tali penahan untuk ekstremitas
n. Pelumas / gel	25. Stetoskop
o. Nasal kanul (dewasa dan anak)	26. <i>Suction</i>
2. Lem perekat	27. Kassa
3. Nebulizer	28. <i>Tourniquet</i>
4. Kapas alkohol	29. Gunting
5. Brankar (dewasa dan anak)	30. Tambahan:
	a. Alat imobilisasi spinal
	b. Ventilator portable

OBAT-OBATAN RUJUKAN (Bila diperlukan)

NAMA OBAT	NAMA OBAT
1. Adenosine, 6mg/2ml	31. Difenhidramin, 50mg/1ml
2. Albuterol, 2,5mg/2ml	32. Dopamine, 200mg/5ml
3. Amiodaron, 150mg/3ml	33. Epinefrin, 1mg/10ml (1:10.000)
4. Atropine, 1mg/10ml	34. Epinefrin, 1mg/1ml (1:1.000)
5. Kalsium klorida, 1g/10ml	35. Fosfenitoin, 750mg/10ml
6. Catacaine/hurricane spray	36. Furosemide, 100mg/10ml
7. Dekstroza 25%, 10ml	37. Glucagon, 1mg (vial)
8. Dekstroza 50%, 50ml	38. Heparin, 1.000 U/1ml
9. Digoksin, 0,5mg/2ml	39. Isoproterenol, 1mg/5ml
10. Diltiazem, 25mg/5ml	40. Labetalol, 40mg/8ml
11. Difenhidramin, 50mg/1ml	41. Lidokain, 100mg/10ml
12. Dopamine, 200mg/5ml	42. Lidokain, 2g/10ml
13. Epinefrin, 1mg/10ml (1:10.000)	43. Manitol, 50g/50ml
14. Epinefrin, 1mg/1ml (1:1.000)	44. MgSO ₄ , 1g/2ml
15. Fosfenitoin, 750mg/10ml	45. Metilprednisolon, 125mg/2ml
16. Furosemide, 100mg/10ml	46. Metoprolol, 5mg/5ml
17. Glucagon, 1mg (vial)	47. Nalokson, 2mg/2ml
18. Heparin, 1.000 U/1ml	48. Nitrogliserin IV, 50mg/10ml
19. Isoproterenol, 1mg/5ml	49. Nitrogliserin tablet, 0,4mg
20. Labetalol, 40mg/8ml	50. Nitroprusid, 50mg/2ml
21. Adenosine, 6mg/2ml	51. Normal Saline – NS, 30 ml untuk injeksi
22. Albuterol, 2,5mg/2ml	52. Fenobarbital, 65mg/ml atau 130mg/ml
23. Amiodaron, 150mg/3ml	53. KCl, 20 mEq/10ml
24. Atropine, 1mg/10ml	54. Prokainamid, 1.000mg/10ml
25. Kalsium klorida, 1g/10ml	55. Natrium bikarbonat, 5mEq/10ml
26. Catacaine/hurricane spray	56. Natrium bikarbonat, 50mEq/50ml
27. Dekstroza 25%, 10ml	57. Akua bidestilata, 30ml untuk injeksi
28. Dekstroza 50%, 50ml	58. Terbutalin, 1mg/1ml
29. Digoksin, 0,5mg/2ml	59. Verapamil, 5mg/2ml
30. Diltiazem, 25mg/5ml	
Obat-obatan berikut ini ditambahkan ke tas emergency segera sebelum rujukan sesuai dengan indikasi pasien:	

1. Analgesik narkose (morfin, fentanil)
2. Sedasi / hypnosis (lorazepam, midazolam, propofol, etomidat, ketamin)
3. Agen neuromuscular blocker (suksinilkolin, pankuronium, atrakurium, rokuronium)
4. Prostaglandin E1
5. Surfaktan paru

3.6 Pemilihan Metode Rujukan

1. Pemilihan metode rujukan harus mempertimbangkan sejumlah komponen penting seperti di bawah ini.
 - f. Derajat urgensi untuk melakukan rujukan
 - g. Kondisi pasien
 - h. Faktor geografik
 - i. Kondisi cuaca
 - j. Arus lalu lintas
 - k. Ketersediaan / availabilitas
 - l. Area untuk mendarat di tempat tujuan
 - m. Jarak tempuh
2. Pilihan kendaraan untuk rujukan pasien antara lain:
 - a. Ambulan transport
 - b. Ambulan Gawat Darurat
 - 1) Siap sedia dalam 24 jam
 - 2) Perjalanan darat
 - 3) Durabilitas: dengan pertimbangan petugas dan peralatan yang dibutuhkan dan lamanya waktu yang diperlukan.

3.7 Alat Transportasi untuk Rujukan

1. Gunakan mobil ambulan Rumah Sakit Prima Husada sesuai kondisi pasien. Mobil dilengkapi soket listrik 12 V, suplai oksigen, monitor, dan peralatan lainnya
2. Sebelum melakukan rujukan, pastikan kebutuhan-kebutuhan untuk men rujukan pasien terpenuhi (seperti suplai oksigen, baterai cadangan, dll).
3. Standar Peralatan di Ambulan Gawat Darurat:
 - a. Suplai oksigen
 - b. Ventilator
 - c. Jarum suntik
 - d. *Suction*
 - e. Baterai cadangan
 - f. *Syringe / infusion pumps* (tinggi pompa sebaiknya tidak melebihi posisi pasien)
 - g. Alat penghangat ruangan portabel (untuk mempertahankan temperatur pasien)
 - h. Alat kejut jantung (*defibrillator*)
3. Tim rujukan/ SDM pendamping dapat memberi saran mengenai kecepatan ambulan yang diperlukan, dengan mempertimbangkan kondisi klinis pasien.
4. Keputusan untuk menggunakan sirene diserahkan kepada supir ambulans. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi rujukan yang lancar dan segera dengan akselerasi dan deselerasi yang minimal.
5. Pendampingan polisi dapat dipertimbangkan pada area yang sangat padat penduduknya
6. Petugas harus tetap duduk selama rujukan dan menggunakan sabuk pengaman.
7. Jika terdapat kegawatdaruratan medis dan pasien membutuhkan intervensi segera, berhentikan ambulan di tempat yang aman dan lakukan tindakan yang diperlukan.
8. Jika petugas diperlukan untuk turun dari kendaraan / ambulan, gunakanlah pakaian yang jelas terlihat oleh pengguna jalan lainnya.

3.8 Dokumentasi Rujukan

1. Lakukan pencatatan yang jelas dan lengkap dalam semua tahapan rujukan, dan harus mencakup :
 - a. Detail kondisi pasien
 - b. Alasan melakukan rujukan
 - c. Nama konsultan yang merujuk dan menerima rujukan
 - d. Status klinis pre-rujukan
 - e. Detail tanda vital, pemeriksaan fisik, dan terapi yang diberikan selama rujukan berlangsung
2. Pencatatan harus terstandarisasi antar-rumah sakit jejaring dan diterapkan untuk rujukan intra- dan antar-rumah sakit
3. Rekam medis harus mengandung :
 - a. Resume singkat mengenai kondisi klinis pasien sebelum, selama, dan setelah rujukan; termasuk kondisi medis yang terkait, faktor lingkungan, dan terapi yang diberikan
 - b. Data untuk proses audit. Tim rujukan harus mempunyai salinan datanya
4. Harus ada prosedur untuk menyelidiki masalah-masalah yang terjadi selama proses rujukan, termasuk penundaan transportasi
5. Tim rujukan harus memperoleh informasi yang jelas mengenai lokasi rumah sakit yang dituju sebelum men rujukan pasien
6. Saat tiba di rumah sakit tujuan, harus ada proses serah-terima pasien antara tim rujukan dengan pihak rumah sakit yang menerima (paramedis dan perawat) yang akan bertanggungjawab terhadap perawatan pasien selanjutnya
7. Proses serah-terima pasien harus mencakup pemberian informasi (baik secara verbal maupun tertulis) mengenai riwayat penyakit pasien, tanda vital, hasil pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi), terapi, dan kondisi klinis selama rujukan berlangsung
8. Hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan yang lainnya harus dideskripsikan dan diserahkan kepada petugas rumah sakit tujuan
9. Setelah menyerahkan pasien, tim rujukan dibebastugaskan dari kewajiban merawat pasien

3.9 Komunikasi dalam Rujukan

1. Pasien (jika memungkinkan) dan keluarganya harus diberitahu mengenai alasan rujukan dan lokasi rumah sakit tujuan. Berikanlah nomor telepon rumah sakit tujuan dan jelaskan cara untuk menuju ke RS tersebut
2. Pastikan bahwa rumah sakit tujuan dapat dan setuju untuk menerima pasien sebelum dilakukan rujukan
3. Kontak pertama harus dilakukan oleh konsultan/ dokter penanggung jawab di kedua rumah sakit, untuk mendiskusikan mengenai kebutuhan medis pasien
4. Untuk kontak selanjutnya, tunjukkan satu orang lainnya (biasanya perawat senior) yang bertugas sebagai komunikator utama sampai rujukan selesai dilakukan
 - a. Jika selama rujukan terjadi pergantian jaga perawat yang ditunjuk, berikan penjelasan mengenai kondisi pasien yang dirujuk dan lakukan penyerahan tanggung jawab kepada perawat yang menggantikan
 - b. Komunikator utama harus menghubungi pelayanan ambulan, jika ingin menggunakan jasanya dan harus menjadi kontak satu-satunya untuk diskusi selanjutnya antara rumah sakit dengan layanan ambulans
 - c. Harus memberikan informasi terbaru mengenai kebutuhan perawatan pasien kepada rumah sakit tujuan
5. Tim rujukan harus berkomunikasi dengan rumah sakit asal dan tujuan mengenai penanganan medis yang diperlukan dan memberikan *update* perkembangannya.

3.10 Audit dan Jaminan Mutu

-
1. Buatlah catatan yang jelas dan lengkap selama rujukan.
 2. Dokumentasi ini akan digunakan sebagai acuan data dasar dan sarana audit
 3. Rumah Sakit Prima Husada bertanggungjawab untuk menjaga berlangsungnya proses pelaporan insidens yang terjadi dalam rujukan dengan menggunakan protokol standar Rumah Sakit Prima Husada
 4. Data audit akan ditinjau ulang secara teratur oleh Rumah Sakit Prima Husada

BAB IV

DOKUMENTASI

Gambar 2.1 PEMBERIAN INFORMASI RUJUKAN

PEMBERIANINFORMASI RUJUKAN

PemberiInformasi		
PenerimaInformasi (Dirisendiri/Suami/Istri/OrangTua/Anak/Wali)		
Pelaksana Tindakan		
JENISINFORMASI	ISIINFORMASI	✓
1. Diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan		
2. Alasan dan Tujuan dilakukan rujukan;		
3. Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;		
4. Transportasi rujukan;		
5. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.		
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menjelaskan hal-hal tersebut di atassecara benar dan jelassertamemberikankesempatanuntukbertanyadan/atauberdiskusi dan pasien memahami. (Pemberi Informasi)		TTD
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana adanyaadi atasyangsudahdiberitanda(✓)dikolomkanannyadan sayatelah memahaminya. (Pemberi Persetujuan)		TTD
Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalahwali atau keluargaterdekat		
PERSETUJUAN / PENOLAKAN RUJUKAN*		
Yang bertandatangan di bawah ini, saya : Nama , usia tahun, L/P* alamat dengan ini menyatakan PERSETUJUAN / PENOLAKAN* untuk dilakukan tindakan terhadap: Diri sendiri/Suami/Istri/Orang Tua/Anak/Wali saya* bernama , usiahr/bln/th, tanggal lahir , L/P* alamat..... Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk risiko yang mungkin timbul apabila tindakan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Saya bertanggungjawab secara penuh atas segala akibat yang mungkin timbul sebagai akibat tidak dilaksanankannya tindakan tersebut. Malang, tanggal20... pk.WIB Yang menyatakan Dokter Saksi Pihak Pasien Saksi Pihak RS (.....) (.....) (.....) (.....)		

Gambar 2.2 FORM KOMUNIKASI PRE-RUJUK

☐ menerima rujukan dari luar ke RS. Prima Husada

☐ komunikasi akan melakukan rujuk dari RS. Prima Husada ke RS lain

IDENTITAS PASIEN	RS LAIN
Nama pasien :	RS yang dituju :

No RM :
.....

Tanggal lahir :
.....

Tanggal masuk : pk
.....WIB

Penjaminan :
.....

Bagian/ nama dokter :
.....

Staf yang menerima : bagian:

No telp :
.....

Diagnosis Kerja :
.....

Indikasi dirawat :
.....

Alasan dirujuk :
.....

HASIL PEMERIKSAAN

TD	Nadi	RR	Tax	Sa02	GCS	bleedin g	Keadaan umum :
mmHg	x/mt	x/mt	C	%		cc	Hamil ☐ Tidak ☐ Ya, G....P....A.... uk
Tindakan				Terapi			
☐ Pasang infus ☐ Injeksi ☐ Rawat luka ☐ hecting ☐ tindakan kegawatan ☐ Nebul ☐ Kateter No ☐ Irigasi mata ☐ NGT ☐				Kebutuhan pelayanan : ☐ RI/ isolasi ☐ Operasi/ ODC ☐ HCU ☐ KKP			
Balasan Rujukan				ACC dirujuk/ TIDAK ACC Hari TanggalJam			
Ketersediaan sarana				:Tersedia/ tidak tersedia,			
Pertimbangan medis kondisi				Kebutuhan transfer pasien			

Petugas RS. Prima Husada

(.....)

Gambar 2.3 FORMULIR RUJUK PASIEN ANTAR RUMAH SAKIT

IDENTITAS PASIEN

TUJUAN RS RUJUKAN

Nama pasien :
.....

No RM :
.....

Kepada:
RS yang dituju :
.....

Tanggal lahir :
.....

Bagian/ nama dokter :
.....

Tanggal masuk : pk
.....WIB

Staf yang menerima :bagian:
.....

Diagnosis Kerja
.....
.....
.....

Indikasi dirawat
.....
.....

HASIL PEMERIKSAAN

Keluhan utama
.....
.....
.....
.....
.....

Riw. Penyakit
.....
.....

Riw. Alergi
.....
.....

Pemeriksaan Fisik
.....
.....
.....

Pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan
.....
.....
.....
.....

Terapi/ tindakan yang telah dilakukan

TINDAKAN	
☐ Pasang infus	☐ Nebul
☐ Injeksi	☐ Kateter No
☐ Rawat luka	☐ Irigasi mata
☐ hecing	☐ NGT
☐ tindakan kegawatan	☐
Terapi :	

Dokter Pengirim

(.....)

KATEGORI PENDAMPINGAN PASIEN TRANSFER		
Derajat	Petugas pendamping (minimal)	Nama petugas pendamping
0	petugas ambulan	
0,5 orang tua/ delirium	petugas ambulan dan paramedis	

1	Petugas ambulan dan perawat	
2	Dokter, perawat, petugas ambulan	
3	Dokter, perawat, petugas ambulan	

KONDISI PASIEN

SEBELUM TRANSFER						SETELAH TRANSFER					
TD	Nadi	RR	Tax	SaO2	TD	GCS	Nadi	RR	Tax	SaO2	GCS
mmHg	x/mt	x/mt	C	%	mmHg		x/mt	x/mt	C	%	

Catatan:

Catatan:

Tanggal transferpk.....WIB
Petugas penyerah pasien,

Tanggal tibapk.....WIB
Petugas penerima pasien

(.....)

(.....)

Gambar 2.4 CHECKLIST PERSIAPAN RUJUKAN

IDENTITAS PASIEN	TUJUAN RS RUJUKAN
Nama pasien : No Rekam Medis: Tanggal lahir : Tanggal masuk : pk WIB	Kepada: RS yang dituju : Bagian/ nama dokter : Staf yang menerima : bagian:
Diagnosis Kerja	
☐ Kelayakan Transfer ☐ Keadaan Umum ☐ Kesadaran :..... ☐ Pemeriksaan Tanda2 Vital: TD:.....mmHg, S:.....°C, N:.....x/mnt, RR ☐ Keluhan :..... ☐ Kesiapan & kemampuan petugas pendamping transfer sesuai Level Kondisi Pasien ... ☐ Dokter ☐ Perawat ☐ TPK/ petugas keamanan ☐ Kesiapan & Kelengkapan Peralatan ☐ Tabung Oksigen (isi penuh), Canul O2 ☐ Tiang Infus ☐ Monitor EKG, Oximetri (bila perlu) ☐ Mesin suction dan Canul (bila perlu) ☐ Alat Resusitasi (Ambu bag, Oropharigeal airway, ETT, Laringoscop) bila perlu ☐ Tensimeter, Stetoscop ☐ Dragbar, Kursi roda ☐ Lain-lain:..... ☐ Hasil pemeriksaan diagnostik yang disertakan ☐ Hasil Laboratorium ☐ Hasil Radiologi ☐ Hasil Lainnya (USG, EKG, EEG, Endoscopi, dll)	

